

PAUSE AR | |

Nouveautés de la semaine du 19 septembre 2026

1 nouveauté cette semaine — aucune ne modifie la pratique dans l'immédiat.

ANESTHÉSIE PÉRIOPÉRATOIRE Essai randomisé

Prospective, randomized comparison of electromyographic neuromuscular responses from the adductor pollicis and abductor digiti minimi muscles during rocuronium-induced neuromuscular block

Anesthesiology · 17 septembre 2026 · 44 patients, les deux muscles enregistrés simultanément

Les recommandations demandent de surveiller la curarisation à l'adducteur du pouce, mais beaucoup d'équipes posent les électrodes sur l'abducteur du cinquième doigt, plus commode. Cet essai a comparé les deux sites chez 44 adultes sous anesthésie générale, un muscle enregistré sur chaque main ; le tirage au sort décidait lequel serait suivi à droite. Ni le délai d'installation du bloc après rocuronium, ni les deux délais de récupération après sugammadex ne différaient significativement d'un muscle à l'autre. Un écart apparaissait toutefois selon la main surveillée : lorsque l'abducteur du cinquième doigt était suivi à droite, le rapport T4/T1 de 0,9 y était atteint 93 secondes plus tôt qu'à l'adducteur du pouce ; les deux muscles donnaient en revanche des délais comparables quand l'abducteur du cinquième doigt était suivi à gauche.

En pratique : surveiller la curarisation à l'abducteur du cinquième doigt reste acceptable pour la conduite courante d'une anesthésie, ce qui conforte une habitude très répandue ; l'adducteur du pouce demeure le site de référence des recommandations. Les deux lectures ne se superposent pourtant pas toujours : quand l'abducteur du cinquième doigt était suivi à la main droite, il a annoncé la récupération 93 à 105 secondes plus tôt que l'adducteur du pouce, suivi à gauche. Ce décalage n'a été relié à aucun événement respiratoire et l'essai ne permet pas de dire qu'il faut choisir un côté plutôt que l'autre avant d'extuber.

[Article original](#)

Tableau de bord complet — toutes les sorties, recherche FR/EN, fiches de lecture : pausear.fr

Fiches rédigées à l'aide de l'IA — résumés à valider par le lecteur avant toute application clinique, se reporter aux articles originaux.